

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE VEINTITRÉS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE AUXILIAR, CATEGORÍA RAMA SANITARIA, DENOMINACIÓN AUXILIAR DE ENFERMERÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

INSTRUCCIONES PARA LOS ASPIRANTES

1º) El Ejercicio consta de 40 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de las preguntas del cuestionario, en un tiempo máximo de 90 minutos.

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con **bolígrafo**, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

3º) En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, uniendo los puntos como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

a) EJEMPLO: Si su documento de identificación es X1234567K, deberá consignar 01234567, añadiendo un cero a la izquierda.

4º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas **y firme la cabecera**.

5º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa

Ejemplo:

			
---	---	---	---

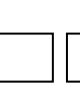
6º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

7º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

8º) El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

9º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 0,50 puntos.

10º) Las preguntas erróneas o no contestadas NO restarán de la puntuación del ejercicio.

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE VEINTITRÉS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE AUXILIAR, CATEGORÍA RAMA SANITARIA, DENOMINACIÓN AUXILIAR DE ENFERMERÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

SUPUESTO 1

A.C.M., de 30 años, vive en un centro de discapacidad desde hace unos meses.

Anteriormente vivía con su familia. La madre es viuda y presenta una enfermedad que le impide seguir cuidándola como lo hacía.

Cuenta, su madre, que desde pequeña le gustaba ver películas y escuchar música usando siempre auriculares. Se agita cuando no consigue lo que quiere.

El personal TCAE observa que le gusta estar sentada sola en un rincón de la sala.

Diagnosticada de autismo, es diabética tipo I, presenta dermatitis, tiene riesgo de atragantamiento porque come muy rápido. Precisa ayuda y/o supervisión para ABVD. Camina sola.

Usa absorbentes solo en la noche, porque en casa, la madre, se los ponía para evitar que se levantara al wc y minimizar el riesgo de caídas.

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1- Al entrar a nuestro turno de mañana, vemos que ayer A.C.M. presentó fiebre. El médico ha pedido que se le realice un urocultivo. ¿En qué envase recogeríamos la muestra?

- a) Frasco de anaerobios.
- b) Frasco de aerobios.
- c) Frasco no estéril.
- d) Frasco estéril.

2- Para el urocultivo se obtendrá la muestra mediante:

- a) Método fraccionado.
- b) Recogida simple.
- c) Recogida compleja.
- d) Método estéril.

3- ¿Qué tipo de protección personal debe utilizarse al manipular muestras biológicas?

- a) Guantes, bata, gafas protectoras y mascarilla.
- b) Guantes y bata.
- c) Gafas protectoras y mascarilla.
- d) Guantes, bata y mascarilla.

4- Cuando el número de micciones al día es mayor de lo normal, pero el volumen al día es normal, se dice que hay:

- a) Polaquiuria.
- b) Poliuria.
- c) Disuria.
- d) Piuria.

5- ¿De qué otra manera se denomina la fiebre?

- a) Hipotermia.
- b) Pirexia.
- c) Hipertermia.
- d) Las respuestas b y c son ciertas.

6- ¿En qué zona del cuerpo la temperatura suele estar más elevada?

- a) Axilar.
- b) Rectal.
- c) Inguinal.
- d) En todas es igual.

7- En la vía de transmisión de un agente infeccioso, el contacto indirecto se puede producir por:

- a) Objetos y materiales contaminados.
- b) De persona a persona.
- c) Contacto físico entre fuentes y huésped.
- d) Ninguna es correcta.

8- Debemos recordar a diario a A.C.M. que debe realizar la higiene bucal. ¿En qué situaciones no se lo recomendaríamos?

- a) Si está consciente.
- b) Si tiene dentadura postiza.
- c) Si esta intubada.
- d) En los tres casos se recomienda la higiene bucal.

9- No es una finalidad en la realización de la higiene y aseo de A.C.M.:

- a) Eliminar microorganismos.
- b) Eliminar secreciones y excreciones corporales.
- c) Estimular la acumulación de secreciones.
- d) Fomentar el descanso y relajación.

10- Cuando vamos a realizar la higiene en la habitación, no es necesario:

- a) Mantener una adecuada temperatura ambiental en la habitación.
- b) Ventilar la habitación antes de proceder a la higiene.
- c) Aislarla del entorno, utilizando un biombo, en caso de compartir habitación.
- d) Evitar las corrientes de aire.

11- A continuación, A.C.M. va a ducharse antes de vestirse. ¿Cuál debe ser aproximadamente la temperatura ambiental para el aseo de la paciente?

- a) 37 °C.
- b) 40 °C.
- c) 15 °C.
- d) 24 °C.

12- ¿En qué casos el uso de guantes sustituye la higiene de manos?

- a) Puede obviarse siempre que se cambien los guantes de una persona a otra.
- b) El uso de guantes nunca sustituye la higiene de manos.
- c) Solamente si se utilizan guantes estériles.
- d) Dependiendo qué técnica vayamos a realizar a la persona.

13- Vamos a ayudar a A.C.M. a levantarse de la cama. ¿Cómo NO se debe hacer una movilización al paciente?

- a) Arrastrándolo por encima de la cama.
- b) Ayudándonos con la entremetida.
- c) Elevándolo sobre la cama.
- d) Todas las respuestas son correctas.

14- ¿Cuál es la posición más adecuada para ayudar a la residente a levantarse de la cama?

- a) De pie, frente a ella, sujetándola por los hombros.
- b) De pie, detrás de ella, sujetándola por la cintura.
- c) Agachado, frente a ella, sujetándola por las rodillas.
- d) De pie, junto a ella, sujetándola por el brazo y la cadera.

15- Si A.C.M. se ha caído y el médico indica que debe ser derivad@ al hospital para valoración y descartar fractura de cadera. ¿Qué es la transferencia en bloque y cuál es su finalidad?

- a) Movilizar a la persona sin ayuda.
- b) Movilizar a la persona con la ayuda de un arnés.
- c) Movilizar a la persona con la ayuda de otra persona.
- d) Movilizar a la persona de una superficie a otra manteniendo su alineación corporal.

16- ¿Qué factor de riesgo de las caídas es extrínseco?

- a) Disminución de la sensibilidad propioceptiva.
- b) Alteraciones oculares de la edad, que disminuyen la agudeza visual.
- c) Gonartrosis.
- d) Uso de calzado inapropiado.

17- A.C.M. sufre una descompensación que le ha provocado una hiperglucemia. El médico sustituye el antidiabético oral que toma por insulina subcutánea 2 veces al día. ¿Cómo debe conservarse esta insulina?

- a) Entre -2 °C y 0 °C.
- b) Siempre a temperatura ambiente.
- c) En el congelador.
- d) En el frigorífico como norma general.

18- Respecto a la administración de medicación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) La vía de administración más rápida es la intravenosa.
- b) Cuando se precisa que el medicamento sea más efectivo, se prefiere la vía intramuscular.
- c) Normalmente, por comodidad, se prefiere la vía oral.
- d) Un inconveniente de la vía oral es que no se puede saber si todo el medicamento será absorbido.

19- La administración sublingual se emplea cuando:

- a) Se desea una acción lenta del medicamento.
- b) Se desea una acción rápida del medicamento.
- c) El paciente no puede tragar medicamentos.
- d) No se puede utilizar ninguna otra vía.

20- Las venas hemorroidales, absorben medicamentos cuya forma de presentación es en forma de:

- a) Pomadas.
- b) Colirios.
- c) Comprimidos.
- d) Enemas.

21- Si observamos que A.C.M. presenta heces pálidas, esto nos puede indicar:

- a) Dieta pobre en carnes.
- b) Infección intestinal.
- c) Obstrucción biliar.
- d) Situación mortal.

22- Si presenta heces negras, a que pueden deberse:

- a) Dieta pobre en carnes.
- b) Infección intestinal.
- c) Sangrado del tracto superior gastrointestinal.
- d) Sangrado del tracto inferior gastrointestinal.

23- A.C.M. presenta un globo vesical y la enfermera va a realizar un sondaje vesical.

¿Cómo realizaría el lavado higiénico de los genitales previo al sondaje?

- a) Lavaría los genitales de abajo hacia arriba con una solución antiséptica y guantes estériles.
- b) Lavaría los genitales con agua y jabón de arriba hacia abajo usando guantes no estériles.
- c) Lavaría los genitales de abajo hacia arriba con agua y jabón prestando especial atención al meato urinario.
- d) Lavaría los genitales con povidona yodada de arriba hacia abajo y aclararía con agua del grifo.

24- Si la enfermera va a realizar un sondaje vesical a A.C.M., debemos tener en cuenta:

- a) El sondaje lo debe realizar el urólogo.
- b) Debemos mantener la esterilidad del medio en la medida de lo posible.
- c) La sonda será extraída de su funda por la enfermera que haga las funciones de campo sucio.
- d) Todas son correctas.

25- La incontinencia por problemas para acceder al lugar adecuado, es:

- a) Incontinencia paradójica.
- b) Incontinencia de estrés.
- c) Incontinencia urinaria funcional.
- d) Incontinencia de urgencia.

26- El médico hace hincapié en que se controle bien la alimentación de A.C.M. Observamos que tiene problemas con la deglución de líquidos (hasta ahora nunca había presentado este problema), ¿qué medidas tomaremos en su dieta?

- a) Usar espesantes para los líquidos, también es preferible dar un plato único muy nutritivo, ya que va a comer más despacio de lo habitual y se va a cansar más.
- b) Dieta de consistencia suave y uniforme, evitaremos dobles texturas en un mismo plato como sopas o bollos mojados en leche.
- c) No hay que tener ninguna medida en la dieta.
- d) Son correctas las respuestas A) y B).

27-¿Qué es una dieta hipoglucémica?

- a) Es una dieta baja en calcio y fósforo.
- b) Es una dieta baja en calorías, en ella se restringen los hidratos de carbono.
- c) Es una dieta caracterizada por ser pobre en residuos.
- d) Dieta muy pobre en grasas.

28- Son nutrientes energéticos:

- a) Los hidratos de carbono y los lípidos.
- b) Las proteínas y los minerales.
- c) Las vitaminas y los minerales.
- d) Las proteínas y las vitaminas.

29-La alteración cognitiva produce un déficit importante en:

- a) La capacidad de la relación social.
- b) Las relaciones familiares.
- c) Las relaciones laborales.
- d) Todas son correctas.

30- A.C.M. se muestra ansiosa y agresiva con el personal de enfermería. ¿Cuál sería la mejor manera de responder utilizando la empatía?

- a) Ignorar a la paciente y continuar con las tareas asignadas.
- b) Discutir con la paciente y tratar de hacerla entrar en razón.
- c) Mostrar comprensión hacia los sentimientos de la paciente y tratar de calmarla.
- d) Llamar a una enfermera para que controle a la paciente.

31-Si observamos que A.C.M. presenta indicios de un posible riesgo autolítico, antes de ser valorada por el facultativo, psiquiatra, psicólogo, etc., que No debemos hacer como TCAE:

- a) Transmitir mensajes no verbales de aceptación y respeto.
- b) Ser condescendientes.
- c) Centrarse en sus sentimientos.
- d) Empatizar, entender sus sentimientos.

32- Los cambios que ponen en riesgo la seguridad de A.C.M. y de todas las personas que conviven con ella en nuestro centro residencial son los producidos a nivel:

- a) Cognitivo.
- b) Afectivo.
- c) Conductual.
- d) Social.

33-¿A qué tipo de modalidad terapéutica, dentro de las restricciones o categorías de contención de las personas con discapacidad como autismo, pertenece la clase que incluye entre otras acciones el control de estímulos y la vigilancia de la existencia de espacios apropiados?

- a) Reducción verbal.
- b) Acción farmacológica.
- c) Reducción física.
- d) Reducción ambiental.

34-Respecto a los medios de contención mecánica sobre las personas es incorrecto que:

- a) Deben aplicarse con suma discreción.
- b) Deben reunir las máximas garantías de seguridad.
- c) No tienen que estar prescritas por el médico.
- d) Deben ser siempre el último recurso ante determinadas conductas.

35- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una habilidad importante para el trabajo en equipo de un auxiliar de enfermería?

- a) Comunicación asertiva.
- b) Liderazgo en solitario.
- c) Empatía.
- d) Capacidad de coordinación.

36- ¿Qué se requiere para una buena coordinación en el trabajo en equipo como auxiliar de enfermería?

- a) Empatía.
- b) Tener habilidades de negociación.
- c) Capacidad multitarea.
- d) Tener muchos conocimientos de farmacología.

37- Entre los riesgos del uso de sujeciones físicas o químicas, están:

- a) Úlceras por presión.
- b) Asfixia.
- c) Muerte súbita.
- d) Todas son correctas.

38- ¿Qué principio es fundamental en el modelo de atención centrado en la persona?

- a) Tratamiento estandarizado para todos los pacientes.
- b) Enfoque principal en la enfermedad y no en el individuo.
- c) Priorizar las necesidades y preferencias individuales del paciente.
- d) Limitar la participación del paciente en su plan de cuidados.

39- ¿Cuál es un objetivo clave de la atención centrada en la persona?

- a) Reducir los costos operativos de la institución de salud.
- b) Aumentar la eficiencia de los procedimientos médicos.
- c) Mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente.
- d) Promover un ambiente de trabajo más cómodo para el personal.

40- ¿Cómo se promueve la autonomía del paciente en el modelo de atención centrada en la persona?

- a) Implementando políticas de cuidado uniforme.
- b) Permitiendo que el paciente participe activamente en su plan de cuidados.
- c) Limitando las opciones de tratamiento disponibles.
- d) Centrándose únicamente en los resultados clínicos.

RESERVA SUPUESTO 1:

41- ¿En qué personas existe el riesgo de que simulen la toma de medicamentos por vía oral?

- a) Enfermos neurológicos.
- b) Enfermos ginecológicos.
- c) Enfermos digestivos.
- d) Enfermos psiquiátricos.

42- Está obligado a guardar secreto profesional:

- a) El médico especialista.
- b) El médico y el técnico especialista.
- c) Todos los que intervengan en la acción sanitaria del paciente.
- d) El médico, el técnico especialista, el enfermero y el TCAE.

43 -Durante la higiene de A.C.M., ¿cómo promoveremos su independencia?

- a) Le pediremos que no se mueva mientras nosotros realizamos el proceso.
- b) Teniendo en cuenta sus limitaciones, le daremos una esponja para que ella misma se enjabone, participando activamente en el proceso.
- c) Si A.C.M. es independiente en su vida diaria, realizaremos la higiene en cama.
- d) Ya que A.C.M. vive en nuestro centro residencial, le instaremos a que no se mueva y se deje hacer todo por el personal para que no empeore su situación.

44- En el uso de inyectables, hay que tener cuidado de no sufrir una inoculación accidental. ¿Cuál es el protocolo a seguir en caso de exposición accidental a un agente biológico?

- a) Lavarse las manos con agua y jabón.
- b) Desinfección y sangrado.
- c) Notificar el incidente al servicio de prevención de riesgos laborales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

45- ¿Cuáles son los 4 principios fundamentales de la bioética?

- a) Libertad, dignidad, justicia y beneficencia.
- b) Dignidad, justicia, beneficencia y maleficencia.
- c) Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía.
- d) Autonomía, justicia, beneficencia y autosuficiencia.

SUPUESTO 2

F.M.D., de 80 años, viudo y tiene 2 hijos que viven fuera de la ciudad, que por motivos laborales no pueden estar todo el tiempo que les gustaría con él.

Jubilado, era profesor en un colegio de educación primaria, la antigua EGB.

Aficionado a la lectura, le gustaba mucho visitar museos y viajar en sus fines de semana.

Diagnosticado de carcinoma de pulmón, ex fumador de 1 “cajetilla al día”, salvo cuando tenía reuniones sociales, que aumentaba el número de cigarrillos que se fumaba. Presenta, también, bronquitis crónica, en tratamiento con O2 domiciliario e HTA.

Desde el punto de vista funcional es dependiente para actividades básicas como el aseo y vestido, aunque comía solo. Pero en las últimas semanas ha empeorado su estado de salud y hace vida cama-sillón. Usa absorbentes día y noche, aunque solicita que lo pongan el en wc.

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1- ¿Cómo realizaremos el baño en cama de F.M.D.?

- a) Lavando cada parte del cuerpo en sentido descendente.
- b) El paciente debe estar en todo momento con buena temperatura corporal.
- c) Se descubrirá únicamente la parte de su anatomía, en la que se esté llevando a cabo el lavado.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2- ¿En qué orden se realiza el baño asistido de una persona encamada?

- a) Cara, manos, brazos y axilas, pecho, abdomen, espalda, zona genital, piernas y por último los pies.
- b) Ojos, cara, cuello y hombros, brazos, manos y axilas, tórax y mamas, abdomen, piernas y pies, espalda y nalgas y por último la zona genital.
- c) Manos, brazos y axilas, cara, cuello, tórax y abdomen, piernas, pies, espalda, nalgas y por último la zona genital
- d) Ojos, cara, cuello, manos, brazos y axilas, tórax y abdomen, espalda, nalgas, genitales y por último los pies.

3- Si F.M.D. se encontrara inconsciente, ¿cómo deberíamos colocarle para realizarle la higiene bucal?

- a) En decúbito prono con la cabeza ladeada.
- b) En posición de Fowler.
- c) En decúbito supino con la cabeza ladeada.
- d) En decúbito supino.

4- Una buena higiene oral es fundamental en el bienestar de los pacientes con cáncer. En una boca dolorosa, las infecciones orales más frecuentes son debidas a:

- a) Infecciones por hongos.
- b) Infecciones por bacterias.
- c) Infecciones víricas.
- d) Las tres son correctas.

5- En el supuesto de que tuviera prótesis dentales, la limpieza debe realizarse con:

- a) Agua fría y aclarado con agua fría o tibia más colutorio.
- b) Agua caliente para una mejor limpieza.
- c) Se puede emplear indistintamente agua fría como agua caliente.
- d) La Tª del agua debe estar entre los 40° y 50°.

6- Durante el turno usted ha acudido en varias ocasiones a cambiarle el pañal y evitar así que la zona perianal se mantenga húmeda y puedan desarrollarse lesiones dérmicas. De todos los cuidados que se muestran a continuación, ¿cuál NO debería haber realizado?

- a) Realizar una higiene completa de la zona expuesta.
- b) Realizar un secado meticuloso, con especial atención a pliegues cutáneos y sin frotar.
- c) Aplicar una solución con alcohol en la zona para evitar infecciones.
- d) Hidratar la piel con algún emoliente y protegerla con productos barrera.

7- ¿Cómo se cortan las uñas de una persona que no lo puede hacer ella sola?

- a) Las uñas de las manos rectas y las de los pies curvas.
- b) Las uñas de los pies rectas y las de las manos curvas.
- c) El corte de uñas se hace igual en manos que en pies.
- d) No se cortan, se deben limar siempre.

8- A F.M.D. le han aislado un germen multiresistente en orina, y le han indicado que permanezca en aislamiento de contacto. ¿Qué materiales y equipos de protección deberán estar disponibles para cuando haya que acceder a la habitación? (Señale la opción más completa).

- a) Bata y guantes.
- b) Bata, guantes, solución hidroalcohólica para higiene de manos.
- c) Bata mascarilla.
- d) Mascarilla FFP3, bata y guantes.

9-Debido a su edad y patologías, F.M.D. es tratado por distintos especialistas médicos. ¿Qué es polifarmacia en el contexto de pacientes geriátricos?

- a) La falta de medicación.
- b) No dar medicación a las personas mayores.
- c) El uso de múltiples medicamentos al mismo tiempo, lo cual aumenta el riesgo de interacciones y efectos secundarios.
- d) No dar importancia a los medicamentos.

10- La enfermera nos ha indicado que le apliquemos una pomada ocular. Se aplicará:

- a) En el párpado superior.
- b) En el canto interno del párpado inferior.
- c) En el canto externo del párpado inferior.
- d) En la córnea.

11- En un paciente con Oxigenoterapia, prestaremos atención a:

- a) La higiene oral y nasal.
- b) Aparición de somnolencia.
- c) Vigilar desconexiones, fugas y acodamientos.
- d) Todas son correctas.

12- ¿Por qué es importante adaptar la banda metálica sobre el tabique nasal?

- a) Ayuda a sujetar la mascarilla y que no se caiga.
- b) Evita fugas hacia los ojos y las mejillas.
- c) No se suele ajustar, ya que la mascarilla se adapta al contorno facial del paciente.
- d) Se deja a la elección del paciente, dependiendo de su anatomía facial.

13-Si una persona tiene problemas respiratorios la colocaremos en posición de:

- a) Sims izquierdo.
- b) Fowler.
- c) Roser.
- d) Decúbito lateral.

14- Al recoger una muestra de orina para su control de diuresis, se observa que tiene color rojo. A esta situación patológica se le denomina:

- a) Disuria.
- b) Hematuria.
- c) Coluria.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15- Indica la definición correcta de cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud:

- a) Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.
- b) Asistencia parcial de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.
- c) Asistencia total inactiva de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.
- d) Asistencia parcial e inactiva de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.

16- Entre los cuidados generales del paciente terminal, el síndrome digestivo más común es:

- a) Caquexia.
- b) Hipo.
- c) Secreciones.
- d) Estertores pre-mortem.

17- Es un signo característico que indica que la muerte de un paciente puede ocurrir de forma inminente:

- a) Manos y pies calientes al tacto.
- b) Aumento de la coloración de la piel.
- c) Disminución o ausencia de movimientos oculares.
- d) Aumento de tono muscular.

18- F.M.D. trata de levantarse sólo para ir al baño y cae al suelo. ¿Cuál es la mejor técnica para levantar a un paciente del suelo?

- a) Levantarlo rápidamente.
- b) Agacharse y levantarlo con la fuerza de la espalda.
- c) Agacharse y levantarlo con la fuerza de las piernas.
- d) Pedir ayuda a otro profesional sanitario.

19- ¿Qué factor NO aumenta el riesgo de caídas en la vejez?

- a) Medicamentos que afectan la coordinación o el equilibrio.
- b) Disminución de la agudeza visual.
- c) Actividad física regular y adaptada.
- d) Obstáculos y desorden en el hogar.

20- ¿Cuál es el objetivo principal de las técnicas de movilización de pacientes?

- a) Facilitar el trabajo del personal sanitario.
- b) Prevenir lesiones y mejorar la movilidad del paciente.
- c) Reducir los costes hospitalarios.
- d) Mejorar la apariencia estética del paciente.

21- ¿Qué posición debe adoptar el paciente para realizar una transferencia de cama a silla de ruedas?

- a) De pie.
- b) Sentado.
- c) Acostado de lado.
- d) Acostado boca arriba.

22- Las sujeciones físicas previenen el riesgo de caída:

- a) Verdadero.
- b) Falso, las pueden aumentar.
- c) No hay evidencia científica que relacione sujeción física y caídas.
- d) La sujeción física está indicada para evitar caídas.

23- Debido a la caída, dejamos a F.M.D. acostado en decúbito supino. ¿Cuál sería la zona de mayor riesgo de ulcerarse?

- a) Talones.
- b) Cresta iliaca.
- c) Maleolos externos.
- d) Rodilla.

24- A F.M.D. se le colocó un colchón antiescaras debido a sus problemas de movilidad. ¿Qué actitud debemos tomar con pacientes que tienen colchón antiescaras?

- a) Debemos realizarle cambios posturales y le aplicaremos ácidos grasos hiperoxigenados aunque tenga colchón antiescaras.
- b) Con el colchón antiescaras no es necesario cambios posturales ni aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados, ya que está totalmente desaconsejado.
- c) Hay que hacerles cambios posturales cada 10 horas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

25- F.M.D. pasa largos periodos de tiempo encamado debido al empeoramiento de su enfermedad. Es un factor intrínseco para la formación de UPP:

- a) Fricción.
- b) Deficiencias Nutricionales.
- c) Humedad.
- d) Presión.

26- Pasados unos días, realizando el baño se ha observado que F.M.D. presenta una úlcera por presión en talón derecho con afectación de epidermis, dermis y con presencia de una ampolla de contenido líquido. ¿En qué grado se clasifica la úlcera que tiene?

- a) Grado I.
- b) Grado II.
- c) Grado III.
- d) Grado IV.

27-Cuál de estas fases no forman parte del proceso de cicatrización de las UPP:

- a) Inflamación.
- b) Epitelización.
- c) Exudado.
- d) Hemostasia.

28- ¿Cuándo se producen las UPP?

- a) Cuando hay mucha grasa en la zona donde aparecen.
- b) Cuando la circulación sanguínea es muy fluida.
- c) Cuando como consecuencia de la presión hay un insuficiente aporte de sangre a los tejidos.
- d) Todas las respuestas son correctas.

29-Una de las complicaciones de las úlceras es la infección, por lo que tendremos que tener especial cuidado en su prevención. Una solución que bloquea la multiplicación y crecimiento de las bacterias se dice que es:

- a) Esterilizante.
- b) Bactericida.
- c) Desinfectante.
- d) Bacteriostática.

30- ¿Qué recomendaciones dietéticas se harán a una persona de edad avanzada?

- a) Dieta hipocalórica para evitar desnutrición.
- b) Ingestión de agua limitada para evitar retención de líquidos.
- c) Dieta rica en proteínas.
- d) Deberá comer pocas veces y abundante.

31- ¿Cuándo está indicada una dieta blanda?

- a) En pacientes diabéticos.
- b) En pacientes con trastornos de corazón y riñón.
- c) En pacientes con edemas.
- d) En pacientes que tienen dificultad para masticar y deglutir.

32-¿Qué es lo primero que debemos hacer, como TCAE, cuando vayamos a administrar la alimentación a F.M.D. y se encuentre encamado?

- a) Colocarle el babero.
- b) Sentarse a su lado, a su altura y evitar prisas.
- c) Informarle del procedimiento y solicitarle su ayuda.
- d) Incorporarlo

33- F.M.D. presenta disfagia, que no mejora. El médico que le atiende indica que se le coloque una sonda nasogástrica para alimentación. Uno de los cuidados de la SNG es administrar, al menos, de 30 a 50 ml de agua tras pasar alimento o medicación por la misma. ¿Por qué motivo se recomienda administrar dicha cantidad de agua por la SNG tras pasar alimento o medicación por la misma?

- a) Para una buena hidratación del paciente.
- b) Porque de este modo nos aseguramos de que todo el contenido de la sonda nasogástrica llega íntegramente al estómago.

- c) Nunca se debe administrar agua tras la alimentación por sonda, ya que podríamos sobresaturar al paciente y provocarle el vómito.
- d) Porque así dejaremos limpia toda la luz de la sonda y evitaremos obstrucciones en la misma.

34-¿A qué velocidad le administraremos a F.M.D. el alimento y la medicación a través de la SNG?

- a) Lo más deprisa posible para que no entre aire.
- b) Lo más lento posible para que no tenga sensación de agobio.
- c) Es indiferente, ya que los pacientes con SNG no perciben sensación gástrica.
- d) Lentamente, evitando burbujas de aire en la medida de lo posible.

35- Tras administrarle la alimentación por SNG, es recomendable:

- a) Ponerlo inmediatamente en decúbito supino para que se eche una siesta tranquilamente.
- b) Ponerlo en decúbito prono para ayudarle a respirar mejor durante la digestión.
- c) Es recomendable dejarlo incorporado a 45° de 30 minutos a 1 hora para evitar regurgitaciones y de este modo evitar broncoaspiraciones indeseadas.
- d) Lo mejor es que el paciente esté en posición de Trendelenburg, así evitaremos hipotensiones.

36- El médico ha indicado que se le administre un enema. Antes de administrarlo tenemos que (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Colocar en decúbito lateral izquierdo.
- b) Colocar la pierna derecha muy flexionada.
- c) Colocar en decúbito lateral derecho.
- d) Lubricar la sonda rectal.

37-Cuando son varios profesionales a la vez los que conocen los detalles y enfermedad del paciente, hablamos de:

- a) Secreto profesional.
- b) Secreto oculto.
- c) Secreto profesional compartido.
- d) Secreto natural.

38-¿Sobre qué tres pilares básicos se sustenta el modelo de cuidados de ACP?

- a) Historia de vida, personal de referencia y plan de cuidados individualizado.
- b) Valoración clínica, recursos económicos, preferencias.
- c) Preferencias, intereses y aficiones.
- d) Historia de vida, diagnósticos médicos y personal técnico.

39-¿Qué define a la Atención Centrada en la persona?

- a) Las decisiones dependen fundamentalmente de los profesionales.
- b) Sitúan el foco en las capacidades y habilidades de la persona.
- c) Se centra en los déficits y necesidades.
- d) Interviene sobre conductas determinadas y patologías.

40-¿Qué aspecto NO es típicamente considerado en la atención centrada en la persona?

- a) Las preferencias personales del paciente.
- b) La historia clínica y antecedentes del paciente.
- c) La autonomía y la toma de decisiones del paciente.
- d) La rentabilidad de los tratamientos aplicados.

RESERVA SUPUESTO 2:

41- Tras la administración de medicación por vía respiratoria (inhaladores presurizados), ¿qué cuidado debemos realizar al paciente?

- a) Poner vaselina en los labios.
- b) Es recomendable tomar un poco de zumo de naranja.
- c) Higiene bucal con agua bicarbonatada.
- d) Permanecer callados durante 10 minutos.

42- ¿Qué dispositivo hay que utilizar para administrar concentraciones altas de O₂ en una persona adulta con problemas respiratorios?

- a) Mascarilla.
- b) Gafas nasales.
- c) Sonda nasal.
- d) Tienda hiperbólica de O₂.

43- ¿Qué método de los siguientes no se considera sujeción física?

- a) Bloquear la puerta para que la persona no salga de la habitación.
- b) Barandilla lateral en la cama para facilitar el volteo de la persona.
- c) Silla de ruedas bloqueada entre la pared y una mesa para que la persona no se levante.
- d) Silla de ruedas basculante para que la persona no se levante.

44- ¿Qué papel juega la familia en la prevención de caídas en los mayores?

- a) No intervenir, ya que la independencia es primordial.
- b) Ayudar a identificar riesgos en el hogar y promover un entorno seguro.
- c) Reducir la visita a los mayores para evitar distracciones.
- d) Aumentar la medicación para mejorar la estabilidad.

45- Los profesionales sanitarios ¿en qué casos se ven obligados a romper el secreto profesional?

- a) En la declaración de las enfermedades infecciosas a los organismos públicos.
- b) En los casos en que se atienden a personas que hayan podido ser víctimas de delito.
- c) En ningún caso.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

ANUNCIO

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE VEINTITRÉS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE AUXILIAR, CATEGORÍA RAMA SANITARIA, DENOMINACIÓN AUXILIAR DE ENFERMERÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL NÚMERO 82 DE 2 DE MAYO DE 2023.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

SUPUESTO 1

1	D	13	A	25	C	37	D
2	D	14	D	26	D	38	C
3	A	15	D	27	B	39	C
4	A	16	D	28	A	40	B
5	D	17	D	29	D		
6	B	18	B	30	C	RESERVA	
7	A	19	B	31	B	41	D
8	D	20	D	32	C	42	C
9	C	21	A	33	D	43	B
10	B	22	C	34	C	44	D
11	D	23	D	35	B	45	C
12	B	24	B	36	A		

SUPUESTO 2

1	D	13	B	25	B	37	C
2	B	14	B	26	B	38	A
3	C	15	A	27	C	39	B
4	D	16	A	28	C	40	D
5	A	17	C	29	D		
6	C	18	D	30	C	RESERVA	
7	B	19	C	31	D	41	C
8	B	20	B	32	C	42	A
9	C	21	B	33	D	43	B
10	B	22	B	34	D	44	B
11	D	23	A	35	C	45	D
12	B	24	A	36	C		

De conformidad con la base séptima de la convocatoria, se concede a las/os aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, a los efectos de que las/los mismas/os formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el Tribunal. Transcurrido dicho periodo sin que se hayan presentado alegaciones o resueltas las mismas, el Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio, así como el lugar, fecha y hora para la realización del segundo ejercicio.

